



REHABILITACION NEUROLOGICA

T.M. Terapia física y rehabilitación

Lic. Yasmin del Rosario Bruno

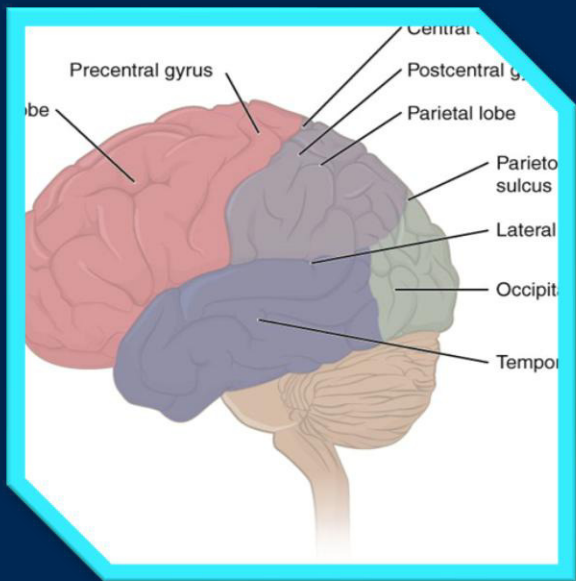
Phowell

Presente.



Hemiplejía: Neurofisiología y Rehabilitación

Objetivos de Aprendizaje



Al finalizar esta sesión, el estudiante será capaz de:

1. Analizar la **fisiopatología** de la lesión de motoneurona superior.
2. Identificar las fases de la **escala de Brunnstrom**.
3. Diseñar estrategias basadas en **neuroplasticidad**.

Vocabulario Especializado

Espasticidad:
Tono muscular
elevado por
hiperexcitabilidad
del reflejo
estiramiento.



Propiocepción:
Capacidad del
sistema nervioso
para detectar
posición corporal.

Vocabulario Especializado



Neuroplasticidad:
Capacidad cerebral de formar nuevas conexiones tras lesiones.



Sincinesia:
Movimientos involuntarios asociados a voluntarios por falta control.

¿Es el daño cerebral el fin del movimiento?

EL DESAFÍO CLÍNICO

Imagina a un paciente que despierta sin sentir la mitad de su cuerpo. La hemiplejía no es solo 'debilidad'; es una desorganización masiva del control motor.

¿Cómo podemos reentrenar un cerebro que ha perdido su mapa principal?



Fisiopatología: El Síndrome de Motoneurona Superior

La hemiplejía surge por lesiones corticoespinales que alteran el control motor.

Signos Positivos

- Espasticidad
- Clonus
- Hiperreflexia

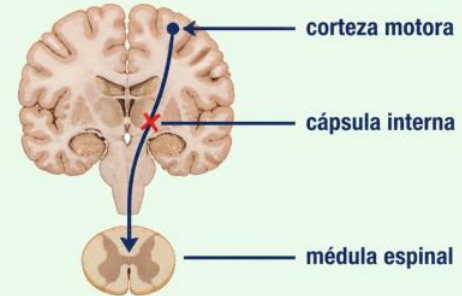
Signos Negativos

- Paresia
- Pérdida de destreza
- Fatiga



Key point

Signos positivos: conductas motoras anómalas.



Evolución Clínica: Etapas de Brunnstrom



La recuperación del paciente hemipléjico suele seguir un patrón predecible de 6 etapas, desde la flacidez inicial hasta la coordinación normal.



Remember

No todos los pacientes alcanzan la etapa 6; muchos quedan estancados en la etapa 3 (espasticidad máxima).

Evaluación de Conceptos

Respuestas en la
siguiente diapositiva...

Durante la evaluación, observas que el paciente presenta una resistencia dependiente de la velocidad al estiramiento pasivo. ¿Cómo se define clínicamente este fenómeno?

1. Rigidez

2. Espasticidad

3. Hipotonía

4. Sincinesia

Evaluación de Conceptos



Durante la evaluación, observas que el paciente presenta una resistencia dependiente de la velocidad al estiramiento pasivo. ¿Cómo se define clínicamente este fenómeno?

1. Rigidez

2. **Espasticidad**



3. Hipotonía

4. Sincinesia

Estrategias de Intervención: Bobath vs Rood

TERAPIA FÍSICA

El enfoque moderno busca la **funcionalidad**.

- **Bobath:** Inhibición de patrones anormales y facilitación del movimiento normal.
- **Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP):** Uso de patrones diagonales para reclutar cadenas musculares.



Example

En el Perú, el uso de técnicas combinadas es el estándar de oro en centros de rehabilitación.



El Fenómeno de la Negligencia

Lesiones del hemisferio derecho pueden causar que el paciente ignore su lado izquierdo (Heminegligencia).



Watch out

La negligencia no es un problema visual, sino un fallo en la atención espacial.

Cuidados posturales en el paciente hemipléjico

PAUTAS A TENER EN CUENTA:

- Hasta que el paciente se adapte a la nueva situación o mejore, extremar las precauciones para evitar que se caiga de la cama, colocando topes en los bordes o juntando uno de los lados de la cama a la pared (el del lado sano).
- Debe recibir la máxima estimulación posible desde el lado paralizado. Por ello, no se debe poner este lado junto a la pared. Hablarle y ofrecerle estímulos visuales desde ese lado.
- Para prevenir lesiones en la piel y contracturas articulares es necesario cambiar frecuentemente de posición, si es posible cada 3 horas. Mantener al paciente limpio y seco y vigilar el aspecto de la piel por si aparecen rojeces.
- No colocar pelotas en la mano afecta ya que provoca que tienda a cerrarse aún más, siendo contraproducente.
- El brazo afecto debe estar en el campo de visión del paciente, evitando que cuelgue o quede bajo el cuerpo.
- No utilizar cabestrillo para sujetar el brazo, salvo que se lo haya indicado su médico rehabilitador.
- Se deben buscar posturas cómodas.
- No traccionar del brazo o la pierna paralizados.
- Comenzar a sentar e intentar ponerle de pie lo antes posible.
- Fomentar siempre la participación del paciente en la medida de sus posibilidades.









NO



NO



NO



GRACIAS

Presente.